

	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction)		จำนวน หน้า
	เรื่อง การพยาบาลเพื่อป้องกันการ การพลัดตกหกล้ม	หน่วยงานที่ใช้ ทุกหอผู้ป่วย	
	รหัสเอกสาร WI-NUR-020	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2565	
หน่วยงาน : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม		ผู้จัดทำ : (นางสาวศิริลักษณ์ เจริญทรัพย์) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
ผู้ทบทวน : (นางสาวจิตตานันท์ ศรีระทัต) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม		ผู้อนุมัติ : (นางสาวนราวดี ปู่สูงเนิน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	

[illegible]

	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction)	เลขหน้า 1/
	เรื่อง การพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม	รหัสเอกสาร WI-NUR-020

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
- 1.2 เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มอย่างครอบคลุม
- 1.3 เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

2. ขอบเขต

- 2.1 ผู้ป่วย และญาติผู้ดูแลที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลปากช่องนานา
- 2.2 ทุกหน่วยงาน

3. นิยามศัพท์

การพลัดตก หมายถึง การเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายจากการลื่น ไหล ถลา หรือตกลงสู่พื้นหรือพื้นผิวที่ต่ำกว่าร่างกาย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจและไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บก็ตาม

๒. อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม หมายถึง จำนวนครั้งของการพลัดตกภายในโรงพยาบาล ต่อจำนวน พันวันนอนของผู้ป่วยทั้งหมดของโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

๓. ระดับความรุนแรงของการพลัดตกหกล้มมี ๙ ระดับ ดังนี้

- A คือ มีสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดการพลัดตกหกล้ม
- B คือ มีสถานการณ์ที่ผู้ป่วยเกือบมีการพลัดตกหกล้ม แต่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทัน
- C คือ ผู้ป่วยพลัดตก หกล้ม แต่ไม่ได้รับการบาดเจ็บ
- D คือ ผู้ป่วยพลัดตก หกล้ม และได้รับการบาดเจ็บเล็กน้อย ได้แก่มีแผลถลอกซ้ำ
- E คือ ผู้ป่วยพลัดตก หกล้ม และได้รับการบาดเจ็บปานกลาง ได้แก่มีแผลเปิดกล้ามเนื้อฉีกขาด มีจ้ำเลือด (Hematoma)มีการเคลื่อนไหวกพร่องจากการตกเตียง ลื่น หกล้มหรืออันตรายอื่นๆ ที่แพทย์มีแผนการรักษา F คือ ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม และได้รับการบาดเจ็บรุนแรง ได้แก่ กระดูกหัก 1 ตำแหน่งหรือหลายตำแหน่ง มี เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง ศีรษะได้รับอันตรายต้องมีแผนการรักษาและทำให้เกิดการพิการชั่วคราว และต้อง รักษาตัวในโรงพยาบาลนานมากขึ้น
- G คือ ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม และได้รับการบาดเจ็บรุนแรงมากส่งผลให้เกิดการพิการถาวร
- H คือ ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม และได้รับการบาดเจ็บรุนแรงมาก และมีการรักษาเพื่อช่วยชีวิต
- I คือ ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

4. ผู้ปฏิบัติงาน

1. พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วย
2. ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ภายในหอผู้ป่วย



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.การเตรียมการ

1.1.การจัดการสิ่งแวดล้อม

1)แสงสว่าง ดูแลบริเวณทางเดิน ทางไปห้องน้ำ

ให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอใน เวลากลางคืนและช่วงเช้า

2)เตียงนอน ควรเป็นเตียงที่ปรับระดับสูงต่ำได้ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเตียง

3)ห้องน้ำ ดูแลพื้นห้องน้ำให้แห้งอยู่เสมอ ไม่ลื่น เมื่อมีน้ำหกให้ทำความสะอาดโดยเร็ว ห้องน้ำมีราวจับกันลื่น หรือราวพยุงซึ่งติดแน่นกับผนัง

4)พื้น ควรเป็นพื้นเรียบ ดูแลพื้นให้แห้งอยู่เสมอ

ไม่มีสิ่งของวางเกะกะบนพื้น ทางเดิน

กรณีพื้นต่างระดับควรมีเครื่องหมายบอกไว้ชัดเจน

2.การพยาบาล

2.1.ให้ความรู้ผู้ป่วยและหรือญาติในการป้องกันการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล และปฐมนิเทศ สิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย

2.2.ประเมินผู้ป่วยแรกรับทุกรายตามแบบบันทึกการพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม (Fall) และ บันทึกในระบบ KPHIS

2.3.จำแนกประเภท ตามคะแนนความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

2.3.1. ผู้ป่วยที่มีคะแนนรวมเท่ากับ 0-24 จัดเป็นกลุ่มไม่มีความเสี่ยง

ให้บันทึกคะแนนใน ระบบ KPHIS เมื่อแรกรับ

การดูแล ได้แก่

1)ยกראวกันเตียงตลอดเวลา เมื่อนอนพักบนเตียง

2)ล็อกล้อเตียงไว้ตลอดเวลา ขณะให้การพยาบาล

3)ดูแลไม่ให้ผู้ป่วยยืนบนเตียง

กรณีผู้ป่วยเด็กเน้นให้ผู้ปกครองดูแลไม่ให้เด็กกระโดดบน

เตียง

2.3.2. ผู้ป่วยที่มีคะแนนรวมเท่ากับ 25-50 จัดเป็นกลุ่มมีความเสี่ยง ให้ใช้แบบบันทึกการพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม (Fall) ใส่ใน Chart ผู้ป่วย ประเมินต่อเนื่องอย่างน้อยแะละ 1 ครั้ง และเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ตามดุลยพินิจของหัวหน้าแะและบันทึกในระบบ KPHIS การ ดูแล ได้แก่

1)ปฏิบัติตามข้อ 2.3.1.

2)ยกראวกันเตียงขึ้นทุกครั้งหลังให้การพยาบาล

3)ประเมินการได้รับยาทางจิตเวช ยาแก้ชัก ยาที่มีผลต่อจิตประสาท

ยาขับปัสสาวะเป็น ต้น รวมถึงอาการวิงเวียน และความสามารถในการทรงตัวของผู้ป่วย

4)ผู้ที่สามารถลุกเข้าห้องน้ำได้ และต้องการทำกิจวัตรประจำวันส่วนตัวที่ห้องน้ำ ให้มี เจ้าหน้าที่ หรือญาติตามดูแลใกล้ชิด



2.3.3. ผู้ป่วยที่มีคะแนนรวมมากกว่าเท่ากับ 51 จัดเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูง ใช้แบบบันทึกการ พยาบาลเพื่อเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม (Fall) ใส่ใน Chart ผู้ป่วย ประเมินต่อเนื่อง อย่างน้อย ทุก 4 ชม. และเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ตามดุลยพินิจของหัวหน้าเวร และ บันทึกในระบบ KPHIS

1) ปฏิบัติตามข้อ 2.3.1. และ 2.2.2.

2) จัดเตียงผู้ป่วย ใกล้เคาน์เตอร์พยาบาลหรือบริเวณที่มองเห็น และเข้าถึงได้ง่าย

3) ปรับระดับเตียงในระดับต่ำ ยกราวกันเตียงไว้ตลอดเวลา และล็อกล้อเตียงเสมอ

4) ติดป้ายสัญลักษณ์เฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มบริเวณหัวเตียงผู้ป่วย

พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้ป่วย และหรือผู้ดูแลเข้าใจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ

5) หากมีความจำเป็นในการผูกยึด เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผูกยึด อย่าง น้อยทุก 2-4 ชั่วโมง

3.การบันทึกทางการพยาบาล และการส่งต่ออาการ

3.1.บันทึกกิจกรรมการดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่พลัดตกหกล้มที่ได้ปฏิบัติลงใน แบบบันทึก ทางการพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม (Fall)

และบันทึกในระบบ KPHIS

3.2.พยาบาลส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการพลัดตกหกล้มขณะรับส่งเวร

4.แนวทางปฏิบัติเมื่อ เกิดอุบัติการณ์พลัดตก หกล้ม

4.1.ผู้พบเหตุ รายงาน หัวหน้าเวร เพื่อทราบ ประเมินอาการผู้ป่วย และรายงานแพทย์

4.2.หัวหน้าเวร โทรศัพท์แจ้งญาติผู้ป่วย เพื่อทราบ และนัดหมายการรับฟังอาการ แผนการ รักษา ชักถามข้อสงสัย และแจ้งความต้องการการดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม จากแพทย์

4.3.หัวหน้าเวร รายงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยทันทีเมื่อเกิดเหตุ

และบันทึกความเสี่ยงตามระบบ

ออนไลน์ผ่านโปรแกรมรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล

4.4.ทีมพยาบาลเฝ้าระวังอาการผิดปกติ และลงบันทึกทางการพยาบาล(Focus)ในระบบ KPHIS

4.5.หัวหน้าเวร รายงาน อาการผู้ป่วยเพื่อทราบ และพิจารณาการดูแลเพิ่มเติม ต่อหัวหน้า หอผู้ป่วย และบันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน

4.6.ประชุมทบทวนเหตุการณ์ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับ E เป็นต้นไป หรือระดับ A-D ที่มี อุบัติการณ์ซ้ำ

4.7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหอผู้ป่วยอื่น พัฒนาแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุม



วิธีการให้บริการตามมาตรฐาน AI2DET

ขั้นตอนหลักในการให้บริการ (Sequence of Service)	ตัวอย่าง ประโยคการสื่อสาร (Communication Dialogue Example)
๑) การทักทาย	• หอผู้ป่วย สวัสดีค่ะ
๒) การแนะนำตัว สร้างปฏิสัมพันธ์	• ดิฉัน.....พยาบาลวิชาชีพ ยินดีให้บริการค่ะ • วันนี้คุณมีอาการอย่างไรบ้างค่ะ เมื่อคืนนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอไหมค่ะ
๓) การระบุตัวผู้รับบริการ	• เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ ขออนุญาตทราบข้อมูลนะคะ ☐ คนไข้ชื่อ.....นามสกุล..... ☐ มีโรคประจำตัวหรือเปล่าค่ะ
๔) การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น	• เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ขออนุญาตประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นนะคะ ☐ ตอนนี้คุณ.....มีอาการสับสน ไม่อยู่นิ่ง จึงขออนุญาตผูกมัดบริเวณ ข้อมือไว้จะคะ เพื่อป้องกันการพลัดตก
๕) การทบทวนข้อมูล	• ขออนุญาตทบทวนข้อมูลที่ได้รับ เพื่อความถูกต้องปลอดภัย ดังนี้ค่ะ ☐ คนไข้ชื่อ.....นามสกุล..... ☐ มีอาการสับสน ไม่อยู่นิ่ง ญาติอนุญาตให้มัดได้ เพื่อป้องกันการ พลัดตกหกล้ม • เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันนะคะ



ขั้นตอนหลักในการให้บริการ (Sequence of Service)	ตัวอย่าง ประโยคการสื่อสาร (Communication Dialogue Example)
๖) การอธิบายขั้นตอน และเชิญ รับบริการ	• ขออนุญาตอธิบายขั้นตอนการป้องกันการพลัดตกหกล้ม โดยใช้เวลา ประมาณ ๕ นาที อาการของคุณตอนนี้ คือไม่อยู่นิ่ง สับสน การปฏิบัติเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มมีขั้นตอนดังนี้ ๑. จัดสภาพแวดล้อมบริเวณเตียงให้เหมาะสม ยกไม้กั้นเตียงขึ้นทุกครั้ง หลังให้การพยาบาล ๒. นำเบาะกันข้างเตียงมาวางบริเวณช่องว่างของเตียง เพื่อป้องกันการ พลัดตกหกล้ม ๓. ขออนุญาตผู้ป่วยและญาติ ในการขออนุญาตบริเวณข้อมือของผู้ป่วย เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มจากเตียง ๔. ใช้ผ้าผูกยึดพันบริเวณข้อมือทั้งสองข้างด้วยความนุ่มนวล และผูกยึดไว้ กับบริเวณเตียง
๗) การแจ้งระยะเวลา ความคืบหน้าในขณะรอคอย	• กรุณารอสักครู่นะคะ • ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังไปเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันการพลัดตกหกล้ม • ผู้ป่วยจะมีความสุขสบายมากขึ้น และปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุพลัด ตกหกล้ม
๘) การอธิบายผลการให้บริการ	• ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการวางเบาะป้องกันการตกเตียง และผูกยึด ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะคะ
๙) การประเมินความเสี่ยงซ้ำ และการประเมินความพึงพอใจ	• ขออนุญาตประเมินความเสี่ยงซ้ำ นะคะ ☐ ต้องการสอบถาม หรือขอคำแนะนำเพื่อเติมอย่างไรบ้างคะ • ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ นะคะ



ขั้นตอนหลักในการให้บริการ (Sequence of Service)	ตัวอย่าง ประโยคการสื่อสาร (Communication Dialogue Example)
๑๐) การขอบคุณ ผู้ป่วย และการให้ข้อมูล หรือ แจ้งขั้นตอนในลำดับ ถัดไป	• ขอบพระคุณที่ให้เราได้ดูแลนะคะ • ขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงและนอนหลับสบายนะคะ • ขอบคุณค่ะ

6. เอกสารหรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง





วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เลขหน้า.....7...../.....7.....

เรื่อง การพยาบาลเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม

รหัสเอกสาร WI-NUR-020



โรงพยาบาลปากช่องนานา

แบบบันทึกการพยาบาลเพื่อเฝ้าระวัง การพลัดตกหกล้ม (Fall)

รหัสเอกสาร : FO-IPD-.....
วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2565
แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่
จัดทำโดย : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

วันที่รับใหม่...../ วันที่รับย้าย.....จาก ward.....
การวินิจฉัยโรค.....

(Fall risk assessment tool: Morse)

รายการ	เกณฑ์การให้คะแนน	วันที่ประเมิน				
1. ประวัติการพลัดตกหกล้ม: มีการพลัดตกหกล้มระหว่างผู้ป่วยหรือตกหกล้มภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา (History of falling: immediate or within 3 months)	ไม่ใช้ 0 คะแนน ใช่ 25 คะแนน					
2. มีการวินิจฉัยโรคมามากกว่า 1 รายการ (Secondary diagnosis)	ไม่ใช้ 0 คะแนน ใช่ 15 คะแนน					
3. การช่วยในการเคลื่อนย้าย (Ambulatory aid) ○ เดินได้เองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย / ใช้รถเข็นนั่ง / นอนพักบนเตียงโดยไม่ให้อุปกรณ์ช่วย (Bed rest) / บุคลากรช่วย (Nurse assist) ○ ไม่ก้ำกั้น (Crutches) / ไม้เท้า (Cane) / walker frame ○ เดินโดยการยึดเกาะไปตามเตียง โต๊ะ เก้าอี้ (Furniture)	0 คะแนน 15 คะแนน 30 คะแนน					
4. ให้สารละลายทางหลอดเลือด (IV) / กา Heparin lock ไว้	ไม่ใช้ 0 คะแนน ใช่ 20 คะแนน					
5. การเดิน (Gait) / การเคลื่อนย้าย (Transferring) ○ ปกติ (Normal) / นอนพักบนเตียงโดยไม่ให้อุปกรณ์ช่วย (Bed rest) / ไม่เคลื่อนไหว (Immobile) ○ อ่อนแรงเล็กน้อยหรืออ่อนเพลีย (Weak) / เดินก้มตัวศีรษะตั้งตรงได้ขณะกำลังเดินโดยไม่ต้องการทรงตัว / เดินก้าวสั้นและลากเท้า ○ มีความพร่อง (Impaired) เช่น ลุกจากเก้าอี้ด้วยความลำบาก พยายามจะลุกเก้าอี้ด้วยการใช้มือและแขนยันตัว หรือลุกด้วยความพยายามอยู่หลายครั้ง เดินก้มศีรษะและตามองที่พื้น เดินโดยต้องมีคนช่วยพยุงหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม่สามารถเดินได้โดยปราศจากการช่วยเหลือ	0 คะแนน 10 คะแนน 20 คะแนน					
6. สภาพจิตใจ ○ รับรู้บุคคล ภาวสถานและสถานที่ได้ด้วยตนเอง (Oriented to own ability) ○ คบสนองไม่ตรงกับความเป็นจริง ประเมินความสามารถของตนเองเกินกว่าที่ทำได้และลืมคิดถึงข้อจำกัดที่มีอยู่ (Forgets limitations)	0 คะแนน 15 คะแนน					
รวมคะแนน						

ระดับความเสี่ยง คะแนน 0 – 24 หมายถึง ไม่มีความเสี่ยงต่อการเดิน/ตก/หกล้ม
คะแนน 25 – 50 หมายถึง มีความเสี่ยงต่อการเดิน/ตก/หกล้ม
คะแนน ≥ 51 หมายถึง มีความเสี่ยงสูงต่อการเดิน/ตก/หกล้ม

ที่มา : <http://www.networkofcare.org/library/Morse%20Fall%20Scale.pdf> December 1, 2012

สรุปผลการเฝ้าระวัง > ☐ ไม่เกิด ☐ เกิดอุบัติเหตุ(ระบุ).....
จำหน่ายจากหอผู้ป่วยวันที่.....
โดย ☐ พยาบาล ☐ สังกัด ☐ ปฏิบัติการรักษา ☐ สังเกตการณ์ ☐ ย้ายไป.....

ติดสติ๊กเกอร์ ข้อมูลผู้ป่วย



ชื่อเอกสาร

ตัวอักษรขนาด 48

รหัสเอกสาร

ตัวอักษรขนาด 36

หน่วยงาน/ทีม โรงพยาบาลปากช่องนานา

ตัวอักษรขนาด 36

ตัวอักษรขนาด 36

ตัวอย่างหน้าปกสำหรับเอกสาร
คุณภาพที่จัดทำเป็นรูปเล่ม



ระบบเอกสารคุณภาพ

HA-SP-001-00

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลปากช่องนานา